



Yth.

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Instalasi Rawat Jalan
3. Kepala Instalasi Rawat Inap
4. Komite Medik
5. SMF Obgyn
6. Maternitas
7. Instalasi Gawat Darurat
8. Asuransi Center
9. Instalasi Rawat Jalan
10. Instalasi Rawat Inap

SURAT EDARAN
NOMOR: 182/I-SE/DIR/III/2026

TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL AUDIT MEDIS SECTIO CAESARIA (REVISI)

Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan audit medis *Sectio Caesaria* (SC) yang telah dilaksanakan oleh Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) BPJS Kesehatan, mohon untuk diperhatikan dan dilaksanakan beberapa perbaikan guna meningkatkan mutu layanan dan kepatuhan administrasi klaim jaminan kesehatan.

Berdasarkan temuan audit medis dan administratif tersebut, berikut ketentuan yang telah ditetapkan :

1. Kepatuhan Terhadap Indikasi Medis Tindakan SC

Prosedur SC harus dilakukan sesuai indikasi medis yang benar, berdasarkan pedoman klinis yang berlaku. Beberapa evaluasi khusus terkait indikasi meliputi:

- a) **Ketuban Pecah Dini (KPD) & BSC 1x:** Kasus KPD harus menyertakan bukti upaya persalinan pervaginam atau induksi, dan BSC 1x tidak dapat langsung dilakukan SC tanpa adanya indikasi lain yang mendukung dan harus tertulis pada lembar observasi ponek mulai dari vital sign sampai VT untuk membuktikan adanya Upaya persalinan pervaginam dahulu
- b) **Kriteria Induksi Gagal :** tidak mencantumkan indikasi gagal maternal maupun fetal, belum mencapai 2 kolf sudah di katakana gagal, BSC 1x tanpa ada indikasi lainnya
- c) **Oligohidramnion:** Wajib menyertakan keterangan AFI pada hasil foto USG, di mana AFI <4 merupakan indikasi absolut SC, jika AFI <8 harus ada penyebab lain yang mendukung
- d) **Lilitan Tali Pusat :** pada kasus persalinan dengan lilitan tali pusat, harus dilakukan upaya partus percobaan dan melampirkan lembar observasi ponek sebagai Upaya persalian pervaginam
- e) **Prolonged kala 1 fase laten :** pada prolonged kala 1 fase laten (pembukaan <3) seharusnya ditunggu atau dipulangkan dahulu sebagai pasien rawat jalan.
- f) **Prolonged kala 1 fase aktif :** harus disertai upaya induksi akselerasi dan didapatkan keterangan kelainan presentasi (letak puncak) pada lembar patograph
- g) **CPD :** Pada diagnosa CPD (disproporsi) harus tertulis di pengkajian awal medis ukuran panggul dalam (baik saat ANC/MRS) alat ukur panggul, tinggi badan dan berat badan.
- h) **Miopia Tinggi:** Kasus miopia (misalnya spheris -7) wajib dikonsultasikan dan disertai hasil pemeriksaan dari Dokter Spesialis Mata yang menerangkan adanya kelainan atau degenerasi retina.
- i) **Primi Tua:** Kondisi primi tua bukan merupakan indikasi absolut untuk prosedur SC.
- j) **Preeklamsia Berat (PEB):** Pastikan diagnosis PEB sudah tegak dengan adanya proteinuria dan tensi tinggi
- k) **Bayi Besar :** harus disertai dengan data dukung berupa (TFU >40 cm, BB bayi saat lahir >3800gr, TBJ dari USG beserta hasil bacaan)
- l) **Fetal Distress:** Diagnosis *fetal distress* dan hasil *Non-Stress Test* (NST) normal, harus disertai dengan bukti tatalaksana awal seperti rehidrasi, pemberian oksigen, dan posisi miring kiri yang tertulis pada lembar observasi ponek, resume medis, dan CPPT.



2. Indikasi Maternal :

- a) **Impending Eklamsia/Eklamsia** : Tercatat tekanan darah, pemeriksaan penunjang lab protein urin, klinis HT/odema tungkai/penurunan kesadaran, nyeri ulu hati, pandangan kabur, mual, muntah
 - Apabila pasien menerima MgSO₄ dilakukan pemeriksaan ureum kreatinin,
 - Apabila pasien terdiagnosis dengan Sindroma HELLP dilakukan pemeriksaan SGOT SGPT
- b) **Solusio plasenta** : lampirkan hasil USG beserta bacaan CTG/NST
- c) **Plasenta previa** : lampirkan hasil USG beserta bacaan
- d) **Ruptur uteri** : (iminens atau komplate) lampirkan hasil USG beserta bacaan
- e) **Prolaps tali pusat** : Palpasi Per Vaginum (VT) dituliskan resume medis pada pemeriksaan fisik / CTG / hasil USG beserta bacaan
- f) **Secondary Arrest** : lampirkan lembar Partograf
- g) **Riwayat Sectio Caesaria sebelumnya** (terutama bila > 2x atau insisi sebelumnya corporil) disertai penyakit lain spt KPP, PEB, Obesitas dll: lampirkan lembar observasi obstetri untuk riwayat SC pada pengkajian awal medis kandungan dan kebidanan
- h) **Penyakit jantung berat** : melampirkan hasil EKG/echocardiografi beserta bacaanya
- i) **Penyakit menular genitalia**: (contoh HIV dengan viral load tinggi atau Sifilis aktif): pemeriksah darah lengkap, triple eliminasi (HIV, siphilis, HbsAg)
- j) **Gagal induksi** : lampirkan lembar Observasi dan Partograf
- k) **Obesitas ekstrem** : lampirkan data berat badan pasien pada lembar pengkajian awal medis kandungan dan kebidanan serta pada resume medis

3. Indikasi janin

- a) **Distress janin akut** : melampirkan hasil CTG/NST beserta bacaan
- b) **Janin IUGR** (<10th centile) dengan aliran doppler abnormal: lampirkan hasil USG Dopler beserta bacaan
- c) **Malpresentasi letak (misal letak sungsang, lintang)** : lampirkan hasil USG beserta bacaan
- d) **Kehamilan ganda dengan presentasi janin pertama bukan kepala** : lampirkan hasil USG beserta bacaan
- e) **Malformasi janin (misalnya hidrocefalus besar)** : lampirkan hasil USG beserta bacaan

4. Kelengkapan dan Konsistensi Rekam Medis

Untuk menghindari temuan administratif dan potensi gagal klaim, DPJP diwajibkan menuliskan rekam medis serta resume medis secara lengkap dan baik.

- a) **Konsistensi Dokumen**: Harus terdapat sinkronisasi pencatatan di seluruh dokumen, mulai dari lembar triase, lembar observasi, CPPT, hingga pengkajian awal dan resume medis.
- b) **Kelengkapan Data Penunjang**: Setiap penegakan diagnosis harus didukung data yang lengkap, seperti melampirkan hasil bacaan USG dan mencatatkan kondisi bayi baru lahir secara detail (berat badan bayi, jenis kelamin, dll) pada laporan operasi.
- c) **Pengisian Partograf**: Seluruh lembar partograf selama proses observasi persalinan wajib diisi secara lengkap tanpa terkecuali.
- d) **Penerimaan Rujukan** : penerimaan rujukan dari bidan praktek atau FKTP wajib dilakukan assessment kembali terkait kesesuaian indikasi dilakukan SC
- e) **Laporan Tindakan operatif memuat informasi**
 1. Operator
 2. Jenis bius yang digunakan
 3. Jenis sayatan terutama sayatan pada uterus
 4. Cara melahirkan bayi saat SC
 5. Perdarahan selama operasi
 6. Komplikasi selama operasi
 7. KB yang digunakan salam operasi bila ada (missal pemasangan IUD atau sterilisasi)



Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 176/I-SE/DIR/III/2026 tentang Tindak Lanjut Hasil Audit Medis Sectio Caesaria tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan panduan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan sesuai standar. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 18 Maret 2026
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes